

ВИНЬЕТКИ

Острый живот

Десять вызовов: панкреатит, внематочная, мезентериальный тромбоз, непроходимость, колика, нижний инфаркт, разрыв трубы, прободная язва, холангит и диабетический кетоацидоз

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1

Мужчина, 52 года. Боль в эпигастрии 4 часа после обеда, постоянная, отдаёт в спину. Сидит, наклонившись вперёд — так легче. Злоупотребление алкоголем. Температура 37,8 °С. АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС 105 в минуту, SpO₂ 97 %. Живот умеренно вздут, болезненный в эпигастрии и левом подреберье, мягкий, без дефанса. Перистальтика ослаблена.

1. Диагноз?
2. Какая поза — ключевая подсказка?
3. Тактика на догоспитальном этапе?

Случай 2

Женщина, 34 года. Боль внизу живота справа 8 часов. Тошнота, однократная рвота. Температура 37,4 °С. АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту, SpO₂ 99 %. Живот мягкий, болезненный в правой подвздошной. Щёткин-Блюмберг слабоположительный справа. Псоас-тест положительный.

Кажется аппендицитом.

1. Какой один вопрос обязателен до рабочего диагноза?
2. Последняя менструация 7 недель назад. Что меняется?
3. Тактика?

Случай 3

Мужчина, 71 год. Боль в животе разлитая, «терпимо». Постоянная фибрилляция предсердий, варфарин. АД 100/65 мм рт. ст., ЧСС 95 в минуту, неритмичный, SpO₂ 96 %, температура 36,8 °С. Живот мягкий, без дефанса, перистальтика обычная, болезненность минимальная, околопупочная. Через 30 минут боль сильнее, беспокоен, живот по-прежнему мягкий.

1. Диагноз? Почему?
2. Что в анамнезе — ключевая подсказка?
3. Почему живот мягкий при сильной боли?
4. Тактика?

Случай 4

Женщина, 78 лет. Рвота 2 дня: сначала пищей, потом «зеленью», сегодня с каловым запахом. Стула нет 3 дня, газы не отходят. Боль схваткообразная. АД 95/60 мм рт. ст., ЧСС 110 в минуту, SpO₂ 96 %, температура 37,0 °С. Сухой язык, тургор снижен. Живот вздут, тимпанит, высокотональная «металлическая» перистальтика. Рубец срединной лапаротомии 20 лет назад.

1. Диагноз?
2. Что в анамнезе — причина?
3. О чём говорит рвота с каловым запахом?
4. Тактика?

Случай 5

Мужчина, 45 лет. Внезапная боль в правой пояснице, иррадирует в пах. Мечется, позы не находит. Тошнота, дизурия. Температура 36,6 °C. АД 150/90 мм рт. ст., ЧСС 95 в минуту, SpO₂ 99 %. Живот мягкий. Поколачивание справа положительное.

1. Диагноз?
2. Пациент мечется — это подтверждает или исключает перитонит?
3. АД 150/90 — красный флаг или ожидаемо?
4. Какое одно исследование подтвердит диагноз?
5. Обезболивание?

Случай 6

Мужчина, 68 лет. Боль в эпигастрии 2 часа, давящая, тошнота, пот. Гипертония, курение 40 лет. АД 90/60 мм рт. ст., ЧСС 55 в минуту, SpO₂ 94 %. Живот мягкий, умеренная болезненность в эпигастрии, без перитонеальных знаков.

1. Какое исследование нужно до пальпации живота?
2. Подъём ST в II, III, aVF, реципрокная депрессия в aVL. Что это?
3. Почему болит эпигастрий, а не грудь?
4. Тактика?

Случай 7

Женщина, 25 лет. Обморок в магазине. Сейчас в сознании, бледная, «ничего не болит». АД 85/50 мм рт. ст., ЧСС 120 в минуту, SpO₂ 98 %. Живот мягкий, слабо болезненный над лобком. Последняя менструация 8 недель назад. Вчера небольшая мазня.

1. Диагноз?
2. Почему говорит, что не болит?
3. Что искать на FAST?
4. Тактика? Куда везти?

Случай 8

Мужчина, 62 года. Полчаса назад схватился за живот, кричал. Сейчас: «Отпустило». Лежит спокойно, улыбается. АД 130/85 мм рт. ст., ЧСС 78 в минуту, SpO₂ 98 %, температура 36,4 °C. Живот мягкий, минимальная болезненность в эпигастрии.

1. Тревожит ли «отпустило»?
2. Какой паттерн боли заподозрить?
3. Через 2 часа: доскообразный живот, ЧСС 120, температура 38,5 °C. Что произошло?
4. Какой диагноз должен был стоять на первом вызове?

Случай 9

Женщина, 42 года. Боль в правом подреберье 6 часов, отдаёт в правую лопатку. Тошнота, рвота. Температура 38,7 °C. Склеры иктеричные. АД 100/60 мм рт. ст., ЧСС 115 в минуту, SpO₂ 97 %. Болезненность в правом подреберье, умеренный дефанс, Мерфи резко положительный.

1. Диагноз?
2. Желтуха + лихорадка + боль — как называется триада?
3. Чем это опаснее обычного холецистита?

4. Тактика?

Случай 10

Мужчина, 19 лет. Боль в животе с утра, многократная рвота, жажда. АД 100/65 мм рт. ст., ЧСС 130 в минуту, SpO₂ 99 %, температура 36,9 °С, ЧД 34 в минуту, дыхание глубокое. Живот болезненный разлитой, мягкий, без дефанса. Запах изо рта фруктовый.

1. Диагноз?
2. ЧД 34 с глубоким дыханием — как называется и зачем?
3. Почему болит живот без хирургической патологии?
4. Три ловушки при ведении.
5. Тактика?

Решения

Случай 1

1. Острый панкреатит.
2. Поза «наклон вперёд» уменьшает давление на забрюшинную поджелудочную. Лежать на спине больнее.
3. Голод, доступ, кристаллоиды, обезбоживание, эвакуация в хирургию. Еда и питьё запрещены. Спазмолитик боль забрюшинного некроза не лечит.

Случай 2

1. Дата последней менструации и возможность беременности. «Эпигастрий и низ живота у женщины 18–45 — спроси про беременность.»
2. Дифференциал смещается на внематочную беременность и другие осложнения беременности. Аппендицит не исчезает, но маршрут и срочность меняются.
3. Тест на беременность, если доступен. Эвакуация в гинекологию или хирургию с предупреждением о возможной внематочной. Не оставлять «наблюдать аппендицит дома».

Случай 3

1. Острая мезентериальная ишемия. Боль сильнее, чем находки на животе; фибрилляция предсердий — источник эмбола.
2. Фибрилляция предсердий. Варфарин не отменяет эмболию, если МНО неизвестно или препарат принимается нерегулярно.
3. Кишка ещё не перитонизировалась. Боль — ишемия стенки, брюшина пока цела. Мягкий живот здесь не успокаивает.
4. Эвакуация в стационар с сосудистой и абдоминальной хирургией. Инфузия, обезбоживание, не кормить. Время решает кишку.

Случай 4

1. Острая тонкокишечная непроходимость, поздняя стадия.
2. Спайки после лапаротомии.
3. Содержимое идёт ретроградно из дистальных отделов. Поздний признак, дефицит объёма уже есть.
4. Назогастральный зонд, если по протоколу бригады. Инфузия, голод, эвакуация в хирургию. Рвота с каловым запахом — не «отравление».

Случай 5

1. Почечная колика, справа, вероятный камень мочеточника.
2. Исключает перитонит. При перитоните лежат неподвижно. Метание — полый орган с перистальтикой или камень.
3. Ожидаемо: боль и катехоламины. У мужчины 45 лет без сосудистого анамнеза это не «гипертонический криз». У мужчины 60+ при колике всё равно пальпируют аорту.
4. Камень подтверждает КТ или УЗИ в стационаре. На линии диагноз клинический.
5. Полноценное обезбоживание по протоколу колики (кеторолак или опиоид — по алгоритму и противопоказаниям). Спазмолитик один не закрывает боль.

Случай 6

1. ЭКГ. Эпигастрий у мужчины 60+ с потом и брадикардией — сначала плёнка, потом живот.
2. Нижний инфаркт с подъёмом ST.
3. Нижняя стенка и диафрагмальная брюшина делят чувствительность. Инфаркт часто приходит как «желудок».
4. Алгоритм ОКС, не спазмолитик. Нитраты при 90 мм рт. ст. и брадикардии нельзя. Красная дорожка. Живот больше не главный сюжет.

Случай 7

1. Прерванная внематочная беременность, геморрагический шок.
2. Кровь в животе раздражает меньше, чем перфорация полого органа. Обморок и бледность — объём, не «головокружение».
3. Свободная жидкость в малом тазу и латеральных каналах. Пустая матка при тесте на беременность — уже стационар.
4. Два доступа, кристаллоид до приемлемой перфузии, транексамовая кислота 1000 мг внутривенно, эвакуация в гинекологию на носилках. Не ждать «чтобы боль появилась».

Случай 8

1. Тревожит. Внезапная «кинжальная» боль с последующим мнимым благополучием — классика прободения.
2. Боль — разлив содержимого. Затишье — химический ожог брюшины ещё не дал бактериального перитонита, пациент истощён болью.
3. Разлитой перитонит. Затишье кончилось.
4. Прободная язва. Первый вызов — тот, который ещё успевает.

Случай 9

1. Острый холангит на фоне холедохолитиаза или холецистита с обструкцией.
2. Триада Шарко: боль в правом подреберье, желтуха, лихорадка.
3. Гной в закрытом желчном дереве, сепсис, рефрактерный шок. Холецистит без желтухи обычно не даёт такую системную цену так быстро.
4. Инфузия, жаропонижающее, эвакуация в хирургию. Антибиотик — стационар. Не «спазмолитик и поликлиника завтра».

Случай 10

1. Диабетический кетоацидоз.
2. Дыхание Куссмауля. Компенсация метаболического ацидоза выдохом углекислоты.
3. Кетоацидоз и гипокалиемия раздражают брюшину и дают илеус. Живот — маска, не аппендицит.
4. Не ставить «острый живот» без глюкозы. Не забивать дыхание оксигенацией «до 100 %» вместо вентиляции. Не вводить инсулин на линии, не закрывая калий: калий уже течёт. Не считать мягкий живот исключением катастрофы — и наоборот, не резать кетоацидоз.
5. Глюкометр, инфузия натрия хлорида, эвакуация в реанимацию или эндокринологию с реанимацией. Инсулин — стационар после калия.

Основные выводы

№	Вывод
1	Наклон вперёд после алкоголя — панкреатит, пока не доказано иное.
2	Низ живота у женщины 18–45 — сначала вопрос о менструации и беременности.
3	Боль сильнее живота при фибрилляции предсердий — мезентериальная ишемия. Мягкий живот не успокаивает.
4	Каловая рвота и металлическая перистальтика — непроходимость, не отравление.
5	Мечется — не перитонит. Колика. У мужчины 60+ всё равно пальпируют аорту.
6	Эпигастрий у мужчины с потом — ЭКГ до пальпации.
7	Обморок, бледность и задержка менструации — внематочная, даже если «не болит».
8	Кинжальная боль, потом «отпустило» — прободение. Затишье врёт.
9	Триада Шарко — холангит, не «желчный приступ».
10	Фруктовый запах и дыхание Куссмауля — кетоацидоз. Глюкоза до хирургии.